

SENA E BITTAR

CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA MÉDICOS

Plano de mentoria

Stanley Bittar e Gilberto Sena · versão 1, 06/out/2026

1. De onde este plano sai

Os quatro pilares, as frases e os indicadores vêm do vídeo de apresentação que vocês já fecharam ([Video Sena e Bittar.mp4](#)). Nada aqui foi inventado:

PILAR	A TESE, COMO ESTÁ NO VÍDEO	O QUE O SISTEMA MEDE
01 Gestão	"A base. O resto se apoia nela."	Sobra do mês, depois de imposto e retirada
02 Marketing	"O paciente certo precisa te encontrar."	Pacientes novos, e quantos vieram por indicação
03 Vendas	"Consulta marcada ainda não é paciente tratado."	Tratamentos fechados, sobre os orçamentos do mês
04 Lucratividade	"Faturar mais e lucrar mais são contas diferentes."	Margem líquida do mês

E o aviso que amarra tudo, também do vídeo: "A agenda lota. O caixa não acompanha. Marketing e vendas em cima de uma base fraca só fazem você trabalhar mais pra sobrar o mesmo."

O método por baixo é o dos **5 G's da Gestão Empreendedora**, livro do Gilberto. A ficha de anamnese de 25 perguntas que já existe ([saídas/ficha-anamnese-mentoria-5gs-2026-08-23/](#)) é a base do diagnóstico, adaptada ao consultório na seção 4.

2. Para quem é, e para quem não é

Quatro públicos, todos donos da própria estrutura. O vídeo já abre o leque: "Vale pra toda a área da saúde."

PÚBLICO	ESTRUTURA TÍPICA
Médico	consultório próprio ou sociedade em clínica
Dentista	consultório odontológico, sozinho ou com equipe
Biomédico	laboratório de análises clínicas, ou atuação em estética
Esteticista	clínica de estética, com ou sem formação na saúde

Os quatro pilares são os mesmos para todos. O que muda de verdade entre eles é a **conta tributária**, e a diferença é grande. Ver a seção 8: médico, dentista e biomédico têm situação confirmada; estética é zona cinzenta. Isso muda o discurso de venda e muda o trabalho.

O vocabulário do consultório também muda: procedimento, sessão, protocolo, pacote. Vale ajustar a conversa, não o método.

Não é para: profissional exclusivamente CLT ou plantonista sem estrutura própria. Sem negócio não existem os quatro pilares, e o programa vira coaching financeiro pessoal, que é outro produto.

A dor que eles trazem, em geral: trabalha mais do que nunca, a agenda está cheia, e não sobra. A promessa do programa é devolver a resposta de *onde o dinheiro está se perdendo* e fechar esse buraco em 90 dias.

Na estética a dor tem um acréscimo: além de não sobrar, o profissional quase sempre não sabe em que alíquota vai cair depois da reforma. Essa insegurança é, hoje, o melhor argumento de entrada desse público.

O que não prometer: faturamento garantido, número de pacientes novos, percentual de crescimento. Os números do vídeo estão marcados "EXEMPLO" de propósito. Manter essa disciplina na venda e na mentoria.

3. O formato

90 dias. É o ciclo que o Gilberto já usa e o que cabe num trimestre fiscal, o que facilita medir.

Encontro de abertura	2h, presencial ou vídeo, os dois sócios presentes
Encontros quinzenais	1h30, 6 encontros ao longo dos 90 dias
Acompanhamento entre encontros	canal direto, resposta em até 1 dia útil
Fechamento	2h, leitura dos quatro indicadores e decisão sobre continuar

Quem conduz o quê. É a frase do vídeo virada em operação: *"O médico e o gestor, do seu lado."*

- **Stanley** abre a porta e traduz. Ele fala a língua do consultório, sabe o que é uma agenda real, um procedimento, um convênio, e por que o médico resiste a certas mudanças. Conduz Marketing e Vendas, que é onde a rotina clínica manda.
- **Gilberto** fecha a conta. Conduz Gestão e Lucratividade: regime tributário, separação de contas, margem por procedimento, precificação.
- **Os dois juntos** na abertura e no fechamento. O resto se divide por pilar, mas cada um acompanha o que o outro decidiu.

4. Fase 1: diagnóstico (dias 1 a 15)

É o "Diagnóstico do seu consultório" que o vídeo promete. Sai um documento, não uma conversa.

4.1 A anamnese do consultório

A ficha dos 5 G's já existe e serve. O que muda para médico é o vocabulário e cinco perguntas que só fazem sentido aqui. Estas entram:

Sobre a base (Gestão)

1. A conta da clínica e a sua conta pessoal são a mesma conta? Com que frequência uma paga a despesa da outra?
2. Você sabe dizer, sem abrir nada agora, quanto sobrou no mês passado depois de imposto e da sua retirada?
3. Qual é o seu regime tributário hoje, e quem decidiu por ele?
4. Você tem pró-labore definido, ou tira conforme o caixa permite?
5. Quanto do seu faturamento vem de convênio e quanto vem de particular?

Sobre o paciente (Marketing)

6. Quando alguém te indica, a pessoa diz o quê sobre você? Por qual procedimento você é lembrado?
7. De onde veio cada paciente novo do mês passado? Você sabe ou chuta?
8. Quem responde a primeira mensagem do paciente, e em quanto tempo?

Sobre a conversão (Vendas)

9. De cada dez orçamentos que você apresenta, quantos viram tratamento?
10. O que acontece com o paciente que ouviu o orçamento e não voltou?
11. Quanto do seu faturamento vem de paciente que já era seu?

Sobre a margem (Lucratividade)

12. Qual dos seus procedimentos dá mais margem? E qual você mais faz?
13. Há quanto tempo você não reajusta preço?
14. Se a sua agenda dobrasse amanhã, o que quebraria primeiro?

Para quem faz estética (pergunta obrigatória)

15. Dos seus procedimentos, quais têm finalidade terapêutica e quais são de embelezamento? Como eles aparecem hoje na nota fiscal?

A pergunta 14 costuma ser a que abre a conversa de verdade. A 15 é a que vale mais dinheiro, pelo motivo da seção 8.

4.2 Levantamento de números

Pedir antes do encontro de abertura, para não queimar a reunião coletando dado:

- Extrato bancário da clínica dos últimos 6 meses
- Faturamento mês a mês dos últimos 12 meses, separado convênio x particular
- Guias de imposto dos últimos 6 meses
- Folha, se houver equipe
- Lista de procedimentos com preço praticado
- Agenda dos últimos 3 meses, com número de atendimentos
- Amostra de notas fiscais emitidas, para ver como o serviço está descrito hoje. É dali que sai o mapa de classificação

4.3 O que é entregue no fim da fase 1

Um documento com:

1. **A linha de base dos quatro indicadores.** Sobra do mês, pacientes novos, conversão de orçamento, margem líquida. Com o método de cálculo escrito, para que o médico saiba de onde saiu cada número.
2. **Onde o dinheiro está se perdendo.** O ranking dos vazamentos, do maior para o menor, em reais por mês.
3. **A conta do regime tributário.** Comparativo do regime atual contra as alternativas, com a conta feita. Ver a seção 8 sobre a reforma.
4. **O mapa de classificação dos serviços.** Cada procedimento da tabela ligado à sua classificação, separando o que é saúde do que é embelezamento. Para médico, dentista e biomédico isso confirma o enquadramento. Para quem faz estética, isso é o trabalho principal, e é onde está o risco e o ganho.
5. **As três decisões do trimestre.** Não dez. Três.

5. Fase 2: plano de ação nos quatro pilares (dias 16 a 75)

Seis encontros quinzenais. A ordem abaixo inverte a numeração do vídeo, de propósito.

Por que a ordem muda

O vídeo numera Gestão, Marketing, Vendas, Lucratividade, que é a ordem da jornada do paciente. Para **executar**, a ordem é outra, e quem diz isso é o próprio vídeo: *marketing e vendas em cima de uma base fraca só fazem você trabalhar mais pra sobrar o mesmo*.

Então: primeiro a base, depois o preço, só então o volume.

Se vocês preferirem manter a numeração do vídeo também na execução, é decisão de vocês. Mas o médico que entra em marketing antes de arrumar preço costuma voltar em seis meses mais cansado e com a mesma sobra.

Encontros 1 e 2: Gestão, a base

O que sai arrumado:

- Conta pessoa física separada da conta da clínica, de verdade, com data
- Pró-labore definido em valor, não em sobra
- Regime tributário decidido e, se for o caso, com o pedido de mudança protocolado ou agendado para a janela certa
- Rotina mensal de fechamento: quem fecha o mês, até que dia, em que planilha ou sistema
- Reserva de caixa, com meta em meses de custo fixo

Ancora no **2G, Gestão Financeira** do livro: governança, orçamento, fluxo de caixa, investimentos, endividamento, nessa ordem de pirâmide.

Encontro 3: Lucratividade, o preço

- Margem apurada por procedimento, não no agregado
- Custo real da hora do médico, incluindo a hora que ele não atende
- Tabela de preço revista, com data de reajuste definida
- Decisão sobre o mix: qual procedimento ganha agenda e qual perde
- A conta do convênio: qual convênio paga a conta e qual é prejuízo disfarçado de movimento

Esta é a sessão que costuma mudar o resultado mais rápido, porque preço corrige margem no mês seguinte, enquanto marketing leva um trimestre.

Encontro 4: Marketing, o paciente certo

- Posicionamento: por qual procedimento este médico quer ser lembrado
- Presença mínima viável, sem virar produtora de conteúdo
- Origem de paciente rastreada: de onde veio cada um, registrado na recepção
- Reputação: avaliação de paciente, indicação ativa, relacionamento com colegas que encaminham

Trava obrigatória: tudo dentro das regras do conselho. Ver a seção 8.

Encontro 5: Vendas, o paciente tratado

- O caminho da primeira mensagem até a consulta, cronometrado
- Quem responde, em quanto tempo, com que script
- A conversa de orçamento: como é apresentada hoje, o que muda
- O retorno do paciente que não fechou: existe ou o orçamento morre sozinho
- Recall e indicação: o paciente que volta e o paciente que traz outro

Ancora no **5G, Gestão de Clientes**: conhecimento, compra, retenção, defesa, recompra.

Encontro 6: amarração

- Revisão dos quatro indicadores contra a linha de base
 - O que ficou pela metade e por quê
 - Gestão de si: a agenda do médico, o que ele parou de fazer para isso caber (**1G**, matriz de urgente x importante)
 - Desenho dos próximos 90 dias
-

6. Fase 3: acompanhamento de perto (dias 76 a 90 e adiante)

O vídeo promete "acompanhamento de perto". Em operação:

- **Painel mensal.** Os quatro indicadores numa tela só, como o vídeo mostra. Quanto entrou e quanto sobrou, de onde vem cada paciente, o que ajustar neste mês.
- **Uma pergunta por mês.** Qual é o ajuste deste mês. Um, não cinco.
- **Revisão trimestral.** Replica o diagnóstico e compara com a linha de base.

O painel é o produto que segura o cliente depois dos 90 dias. Vale discutir se ele entra junto da mentoria ou é a camada de recorrência que vem depois.

7. O que é medido, e como

Os quatro indicadores precisam de fórmula escrita, senão cada mês é medido de um jeito e a comparação não vale.

Os nomes abaixo são os do painel que aparece no vídeo, letra por letra.

PILAR	INDICADOR	COMO CALCULAR
Gestão	Sobra do mês , depois de imposto e retirada	Receita recebida no mês, menos custo fixo, menos custo variável, menos imposto pago, menos pró-labore. É caixa, não competência.
Marketing	Pacientes novos , e quantos por indicação	Primeira consulta no período, por origem registrada na recepção. Paciente que volta depois de anos conta como retorno. A fatia que veio por indicação é o número que mostra reputação.
Vendas	Tratamentos fechados , sobre os orçamentos do mês	Orçamentos que viraram tratamento iniciado, dividido pelos orçamentos apresentados no mesmo período.
Lucro	Margem líquida , contra a meta do trimestre	Sobra do mês dividida pela receita do mês. É o número que mostra se faturar mais virou lucrar mais.

O painel do vídeo ainda traz faturamento e lucro dos últimos 12 meses lado a lado, que é o gráfico que o médico entende sem explicação.

Medir a linha de base no diagnóstico e repetir todo mês, com a mesma conta.

8. Duas coisas que precisam ser fechadas antes de vender

8.1 A conta da reforma tributária, público por público

Isto está fichado e confere. **Os quatro públicos não estão na mesma situação**, e essa diferença é o coração do argumento de venda.

PÚBLICO	SITUAÇÃO NA REFORMA	FICHAMENTO
Médico	60% de redução confirmada , por prestar serviço de saúde (arts. 128-134 da LC 214/2025). O CFM articulou isso no Congresso.	reforma-tributaria-medicos.md
Dentista	60% confirmada , mesma lógica. O CFO articulou. Ganho extra: a não-cumulatividade deixa a clínica creditar imposto pago em despesa e custo da atividade.	reforma-tributaria-odontologia.md
Biomédico	Incluído entre os cerca de 30 serviços de saúde do Anexo VIII, laboratório de análises clínicas citado de forma explícita.	reforma-tributaria-biomedicina.md
Estética	Não tem inclusão confirmada . É zona cinzenta, com risco real de disputa jurídica.	reforma-tributaria-clinicas-esteticas.md

A regra que vale para os três primeiros: a redução de 60% de saúde e a de 30% de profissão regulamentada **não somam**. Quando o serviço é saúde, aplica-se a de 60%, que é a maior. A de 30% é alternativa, não acréscimo.

Por que estética é diferente, e por que isso é oportunidade:

O que decide não é quem faz, é **como o serviço é classificado** na NBS:

- Procedimento com finalidade **terapêutica** (reconstrução, tratamento de patologia), feito por médico: tende a entrar como saúde, 60%.
- O **mesmo** profissional fazendo procedimento puramente de embelezamento, sem finalidade terapêutica: pode não entrar como saúde. Cairia nos 30% de profissão regulamentada, se ainda contar como atividade ligada à qualificação, ou na alíquota cheia se nem isso.
- **Esteticista sem formação na saúde:** risco real de não se enquadrar em nenhuma redução.

Ou seja: a clínica que mistura procedimento terapêutico com procedimento estético precisa saber separar as duas coisas na classificação. Esse é um trabalho de consultoria real, com valor em reais, e é exatamente o que ninguém está fazendo por esse público hoje.

O que não afirmar, em venda nem em mentoria:

- Que estética paga sempre alíquota cheia. Depende do procedimento.
- Que estética tem direito aos 60%. A própria fonte diz que é controverso.
- Que todo procedimento médico ou odontológico entra automaticamente nos 60% sem checar a classificação.
- Número fechado de alíquota. O padrão (26,5% a 28%) ainda não está definido. A estimativa publicada para odontologia, cerca de 11,2% num padrão de 28%, é projeção e deve ser dita como projeção.

8.2 As regras dos conselhos sobre publicidade: não tenho

O pilar de Marketing promete "tudo dentro das regras do conselho", e agora são conselhos no plural: CFM para médico, CFO para dentista, CFBM para biomédico. Para o esteticista sem formação na saúde não há conselho equivalente, o que muda a régua de publicidade e precisa ser verificado.

Não existe nada fichado aqui sobre publicidade em nenhum dos quatro casos, e eu não vou citar número de resolução de cabeça. Até isso ser levantado, o pilar de Marketing não deveria ser vendido com promessa de conformidade.

Dá para resolver rápido com uma pesquisa dedicada. É o item 1 da lista abaixo.

9. O que falta decidir

1. **Levantar as regras de publicidade dos conselhos** (CFM, CFO, CFBM e o que vale para esteticista sem conselho) e fichar, antes de vender o pilar de Marketing. Bloqueia a venda do pilar.
2. ~~Preço do programa:~~ **Decidido em 06/out/2026**. Ver seção 11.

3. **Divisão entre os sócios.** Como entra a receita e como se divide.
4. **O painel é parte da mentoria ou é a recorrência depois dela?**
5. **A marca fala "para médicos", mas o público agora é quatro.** Decidir se a assinatura muda, se cada público ganha uma peça própria, ou se médico segue como porta de entrada e o resto entra por indicação.
6. **Contrato de prestação de serviço** da mentoria, com sigilo. Existe modelo em [juridico/](#) para adaptar.

10. Próximas peças que saem deste documento

- ~~A ficha de diagnóstico do consultório, em PDF.~~ **Pronta em 06/out/2026**, em [ficha-diagnostico/](#). São 6 páginas, 21 perguntas divididas pelos quatro pilares, mais a folha de fecho com a linha de partida. A pergunta 21 só vale para quem faz estética.
- O modelo do documento de diagnóstico que fecha a fase 1
- A peça comercial de uma página para o médico
- O roteiro do diagnóstico gratuito, que é o que o QR code do vídeo promete

11. Preço

Decidido pelo Gilberto em 06/out/2026.

FORMA	VALOR
À vista, pix ou cartão	R\$ 45.000,00
Parcelado	12x de R\$ 5.000,00 , total de R\$ 60.000,00

Uma observação de quem faz a conta. A diferença entre as duas formas é de R\$ 15.000, o que embute uma taxa de **4,73% ao mês**, ou 74,1% ao ano. É uma escolha legítima: parcelamento no cartão tem custo de adquirente, e o risco de inadimplência ao longo de doze meses é real. Mas é um número alto o bastante para o médico fazer a conta sozinho, e vários deles fazem.

Duas formas de tratar isso, as duas defensáveis:

- **Deixar como está e saber defender.** Se alguém perguntar, a resposta é o custo do parcelamento e o risco do prazo. Resposta honesta, dita sem rodeio.
- **Baixar a taxa embutida sem mexer no caixa.** Algumas contas, todas com a mesma entrada de R\$ 45.000 à vista:

PARCELAMENTO	TOTAL	TAXA EMBUTIDA
12x de R\$ 5.000	R\$ 60.000	4,73% a.m. · 74,1% a.a.
6x de R\$ 8.500	R\$ 51.000	3,70% a.m. · 54,6% a.a.
6x de R\$ 8.200	R\$ 49.200	2,61% a.m. · 36,2% a.a.
12x de R\$ 4.200	R\$ 50.400	1,79% a.m. · 23,7% a.a.

A última linha é a que eu acharia mais fácil de defender: mantém os doze meses, que é o que o médico quer, e a taxa embutida fica abaixo do que ele paga no capital de giro dele.

A decisão é sua. Só não quero que o número apareça numa reunião sem você ter visto ele antes.

